TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)

À RETENIR

- TEP de perfusion : ↑ Se, ↑ Sp, ↑ résolution, ↓ faux positifs grâce à la correction d'atténuation (obèses…).
- Quantification de la réserve coronaire : RC = débit en vasodilatation / débit basal ; utile dans le tritronculaire.
- Dosimétrie **< 3 mSv**.
- Viabilité : FDG + traceur de perfusion (ou ^{11}C-AG, acides gras), sous charge glucose/insuline.
- Inflammation/infection : FDG + préparation ; innervation : ^{11}C ; plaque d'athérome : inflammation.
- Limites : protocoles non codifiés, coût, disponibilité.

Applications

1. **Perfusion** :
   - ↑ sensibilité, ↑ spécificité ;
   - ↑ résolution ;
   - ↓ faux positifs = correction d'atténuation (obèses…) ;
   - quantification = réserve coronaire (RC = débit en vasodilatation / débit basal) ;
   - tritronculaire ;
   - FE ;
   - dosimétrie **< 3 mSv**.
2. **Viabilité** : FDG + traceur de perfusion ou ^{11}C-AG (acides gras) ; ↑ glucose, ↑ insuline.
3. **Inflammation + infection** : FDG + préparation.
4. **Innervation** : traceurs au ^{11}C.
5. **Plaque d'athérome** : inflammation.

Mais — Protocoles non codifiés + coût + disponibilité.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avantages de la TEP de perfusion ?	↑ Se, ↑ Sp, ↑ résolution, ↓ FP (correction d'atténuation), quantification de la RC, FE, dosimétrie < 3 mSv.
2. Comment définit-on la réserve coronaire ?	Débit en vasodilatation / débit basal.
3. Protocole TEP de viabilité ?	FDG + traceur de perfusion, sous charge glucose/insuline.
4. Limites de la TEP cardiaque ?	Protocoles non codifiés, coût, disponibilité.